

Dolor ocular agudo

1. Introducción y relevancia clínica

El **dolor ocular agudo** constituye uno de los **motivos más frecuentes de consulta oftalmológica en urgencias**.

Su espectro clínico es amplio: desde cuadros benignos (como cuerpo extraño superficial) hasta patologías potencialmente **devastadoras para la visión**, como el **glaucoma agudo de ángulo cerrado**, la **queratitis infecciosa** o la **endoftalmitis**.

El médico general y el médico de urgencia deben ser capaces de:

- Reconocer signos de alarma que requieren derivación inmediata.
- Iniciar manejo analgésico y antibiótico tópico cuando corresponda.
- Evitar maniobras o fármacos que puedan agravar el cuadro (p. ej., dilatación pupilar en glaucoma agudo).

Relevancia en EUNACOM

El **dolor ocular agudo** suele presentarse en las preguntas clínicas del examen como:

“Paciente de 65 años con dolor ocular intenso, visión borrosa, halos de colores y náuseas.”

El diagnóstico correcto (glaucoma agudo) y la conducta inicial (bajar la presión intraocular y derivar urgente) son **objetivos recurrentes de evaluación**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El dolor ocular agudo puede originarse en:

1. **Estructuras superficiales (córnea, conjuntiva, esclera).**

→ Dolor punzante, sensación de cuerpo extraño.

2. **Estructuras profundas (iris, cuerpo ciliar, cámara anterior).**

→ Dolor intenso, irradiado a cabeza, con fotofobia y náuseas.

3. **Aumento brusco de la presión intraocular (PIO).**

→ Dolor profundo, hemicraneal, con halos de colores.

4. **Procesos inflamatorios o infecciosos severos (endofthalmitis, queratitis ulcerada).**

→ Dolor severo con disminución de agudeza visual marcada.

El dolor ocular se transmite a través del **nervio trigémino (V par craneal)**, principalmente por sus ramas **nasociliar y frontal**, motivo por el cual puede confundirse con cefalea o dolor facial.

Principales mecanismos fisiopatológicos

Mecanismo	Ejemplo	Características
Irritación corneal / epitelial	Cuerpo extraño, abrasión, queratitis	Dolor agudo, lagrimeo, blefaroespasmo.
Inflamación del cuerpo ciliar (iridociclitis)	Uveítis anterior	Dolor profundo, miosis, fotofobia.
Aumento de la presión intraocular (PIO)	Glaucoma agudo	Dolor intenso, cefalea, visión de halos.
Inflamación intraocular difusa	Endofthalmitis	Dolor severo, pérdida visual rápida.
Espasmo muscular periorbitario	Neuralgia, trauma	Dolor difuso, sin hallazgos oculares.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El **diagnóstico diferencial** del dolor ocular agudo debe realizarse con base en tres preguntas clave:

- 1. ¿Existe **disminución de agudeza visual**?
→ Sí: cuadro potencialmente grave.
- 2. ¿Hay **hiperemia conjuntival localizada o difusa**?
- 3. ¿Se acompaña de **fotofobia, secreción o visión de halos**?

3.1 Diagnóstico diferencial principal del dolor ocular agudo

Etiología	Características clínicas	Hallazgos clave	Dolor
Cuerpo extraño / erosión corneal	Antecedente traumático, sensación de arenilla	Lesión con fluoresceína positiva	Moderado
Queratitis infecciosa (bacteriana o herpética)	Dolor, ojo rojo, secreción, disminución de visión	Úlcera corneal, tinción irregular	Intenso
Conjuntivitis aguda	Ojo rojo difuso, secreción, sin pérdida visual	Secreción mucosa o acuosa	Leve
Uveítis anterior (iridociclitis)	Dolor profundo, fotofobia, miosis	Flare y células en cámara anterior	Moderado a intenso
Glaucoma agudo de ángulo cerrado	Dolor ocular y cefalea, visión borrosa, halos, náuseas	PIO elevada, córnea opaca, pupila media fija	Muy intenso

Escleritis	Dolor profundo que despierta al paciente	Hiperemia azulada, no blanquea con vasoconstrictor	Intenso
Endoftalmitis	Postoperatorio o trauma, dolor, pérdida visual	Cámara anterior turbia, hipopión	Muy intenso
Neuralgia del trigémino	Dolor paroxístico facial, sin alteraciones oculares	Examen ocular normal	Variable

3.2 Semiología orientadora

Signo / Síntoma	Diagnóstico probable
Dolor con fotofobia + miosis	Uveítis anterior
Dolor con halos de colores + náuseas	Glaucoma agudo
Dolor punzante + cuerpo extraño	Erosión corneal
Dolor severo + cirugía ocular reciente	Endoftalmitis
Dolor leve + secreción purulenta	Conjuntivitis bacteriana
Dolor con visión borrosa y blefaroespasma	Queratitis infecciosa

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En atención primaria o urgencia

1. Agudeza visual (monocular).

Si hay pérdida visual → derivar urgente.

2. Tinción con fluoresceína (bajo luz azul).

- Identifica erosiones, úlceras o cuerpos extraños.

3. Prueba del reflejo pupilar.

- Pupila media fija → glaucoma agudo.
- Miosis dolorosa → uveítis.

4. Medición de presión intraocular (PIO) — si disponible.

5. Evaluación con lámpara de hendidura (si hay acceso).

4.2 En nivel especializado (oftalmología)

Examen	Utilidad
Biomicroscopía	Diferencia queratitis vs uveítis.
Tonometría de aplanación	Diagnóstico de glaucoma agudo.
Cultivo de secreción o córnea	En úlceras severas o recurrentes.
Ecografía ocular modo B	Si medios opacos.
Fondo de ojo indirecto	Si no hay contraindicación (no en glaucoma agudo).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF)

El tratamiento debe **iniciarse según la sospecha clínica**, evitando maniobras que agraven el cuadro (como dilatar pupila sin descartar glaucoma).

5.1 Conducta según diagnóstico principal

A. Glaucoma agudo de ángulo cerrado (emergencia vital y visual)

Cuadro: Dolor ocular severo, visión borrosa, halos, pupila media fija, PIO >40 mmHg.

Tratamiento inmediato:

1. **Acetazolamida 500 mg EV o VO** (disminuye producción de humor acuoso).
2. **Manitol 20% 1 g/kg EV** en casos severos.
3. **Colirios:**
 - **Timolol 0,5% (betabloqueador).**
 - **Brimonidina 0,2% (alfa agonista).**
 - **Pilocarpina 2%** tras reducción parcial de PIO (favorece apertura del ángulo).
4. Analgesia y antieméticos.
5. **Derivación urgente a oftalmología para iridotomía láser.**

B. Uveítis anterior (iridociclitis)

Cuadro: Dolor ocular profundo, fotofobia, miosis, visión borrosa.

Tratamiento inicial:

- **Midriáticos/ciclopléjicos (atropina 1% o ciclopentolato 1%)** para aliviar espasmo del músculo ciliar.
- **Corticosteroides tópicos (prednisolona 1%)** bajo control oftalmológico.
- Evaluar **etiología sistémica** (autoinmunidad, infección, trauma).

C. Queratitis bacteriana

Cuadro: Dolor, ojo rojo, secreción purulenta, disminución de visión.

Tratamiento:

- **Antibióticos tópicos de amplio espectro:**
 - **Fluoroquinolonas (moxifloxacino o ciprofloxacino 0,3%)** cada 1–2 h.
- Suspender lentes de contacto.
- Evitar corticoides tópicos en fase aguda.
- **Derivación urgente si úlcera central o perforante.**

D. Queratitis herpética (HSV-1)

Cuadro: Dolor, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, úlcera dendrítica.

Tratamiento:

- **Aciclovir ungüento oftálmico 5 veces/día por 7 días.**
- **Evitar corticoides tópicos** (agravan el cuadro).
- Derivación a oftalmología para seguimiento.

E. Cuerpo extraño / abrasión corneal

Tratamiento inicial:

- Remover cuerpo extraño si visible y superficial.
 - **Colirio antibiótico profiláctico (eritromicina o gentamicina).**
 - Analgésicos sistémicos.
 - Evitar parches oculares (favorecen infección).
-

F. Endoftalmitis (postoperatoria o postraumática)

Cuadro: Dolor intenso, pérdida visual rápida, hipopión.

Tratamiento urgente:

- Antibióticos intravítreos (vancomicina + ceftazidima).
 - Hospitalización y cirugía (vitrectomía) según caso.
 - No administrar corticoides tópicos sin indicación oftalmológica.
-

G. Escleritis

Cuadro: Dolor profundo que despierta al paciente.

Tratamiento:

- AINES o corticoides sistémicos.
 - Investigar enfermedades reumatológicas (AR, LES, vasculitis).
 - Derivación urgente.
-

5.2 Medidas generales

- Analgesia sistémica (AINE o paracetamol).
 - No ocluir el ojo salvo indicación precisa.
 - Suspender uso de lentes de contacto.
 - Educación al paciente sobre signos de alarma.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Patología

Complicaciones

Pronóstico

Glaucoma agudo	Atrofia del nervio óptico	Grave sin tratamiento precoz
Uveítis anterior	Sinequias, catarata, glaucoma secundario	Bueno con tratamiento
Queratitis bacteriana	Ulceración corneal, perforación	Variable
Queratitis herpética	Recurrencias, cicatrices corneales	Moderado
Endoftalmitis	Pérdida visual total	Malo
Escleritis	Perforación, necrosis escleral	Variable

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Glaucoma agudo = dolor + halos + pupila media fija + náuseas.**
 2. **Nunca dilatar la pupila** sin descartar glaucoma agudo.
 3. **Queratitis herpética** → **úlceras dendríticas** y se agrava con corticoides.
 4. **Endoftalmitis** postcirugía o trauma → **emergencia absoluta.**
 5. **Uveítis** presenta miosis dolorosa y mejora con ciclopléjicos.
 6. **Cuerpo extraño superficial** se ve mejor con fluoresceína bajo luz azul.
 7. Siempre preguntar por **uso de lentes de contacto.**
-

Errores comunes

- Usar colirios con corticoides en úlceras corneales sin diagnóstico.
 - No medir o sospechar presión intraocular elevada.
 - No derivar a oftalmología ante pérdida visual acompañante.
 - Ocluir el ojo lesionado con parche.
 - Diagnosticar “conjuntivitis” en casos de glaucoma o queratitis.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **dolor ocular agudo** puede deberse a patologías benignas o graves; **la disminución de visión indica urgencia oftalmológica.**
2. **Glaucoma agudo de ángulo cerrado** es la causa más grave: dolor, halos, náuseas y pupila media fija.
3. **No usar midriáticos ni corticoides** hasta descartar glaucoma o úlcera herpética.
4. **Queratitis bacteriana y herpética** requieren antibióticos o antivirales tópicos específicos.
5. **Uveítis anterior** mejora con midriáticos y corticoides bajo control oftalmológico.
6. **Endoftalmitis** es una emergencia vital-ocular: requiere antibióticos intravítreos inmediatos.
7. Todo **dolor ocular con pérdida de visión** debe derivarse **urgente a oftalmología.**